

Tableau de synthèse justifiant le choix des variables

Type de variable	Code variable	Risques associés à l'apparition de maladies CNV	Sources
Gradient social de santé (statut professionnel, éducation, inégalités de revenus)	PCS_6_rate, Taux de chomeurs_2022, DIPLOME, MED_SL, PR_MD60, IR_D9_D1_SL, FDep_2021, EDI_Moyenn.	L'usure professionnelle et le stress financier chronique augmentent la pression artérielle et favorisent l'obésité viscérale. Une faible littératie en santé chez les moins diplômés nuit à la prévention, doublant la prévalence de l'hypertension et triplant celle du diabète. Les contraintes budgétaires (faible niveau de vie) poussent à consommer des produits ultra-transformés et salés qui augmentent le risque cardiovasculaire. Les fortes inégalités de revenus (rapport interdécile) érodent la cohésion sociale et augmentent le stress psychosocial. Les indices de défavorisation (FDep, EDI) montrent un gradient net d'incidence d'AVC et d'infarctus, avec un risque d'hospitalisation pour AVC multiplié par 1,3 dans les zones les plus pauvres.	Les inégalités sociales de santé - Drees, Santé et précarité énergétique - ONPE, Réduire les inégalités sociales en santé - solidarites.gouv, Les maladies cardiovasculaires en France : un impact majeur et des inégalités persistantes - Santé Publique France
Isolement social et solitude	Part pop. RSA, Part C2S, Limitations physiques, VQS_F_6074_aide_prouches_Oui_p, Taux de co-résidence, Part bénéficiaires APA.	L'isolement social augmente de 60 % à 70 % le risque de décès toutes causes, un impact comparable à fumer 15 cigarettes par jour. Il induit une hausse chronique de la pression artérielle et une rigidification des parois artérielles qui fragilise les plaques d'athérome, augmentant le risque de thrombose. Chez les insuffisants cardiaques, vivre seul double le risque de réhospitalisation pour décompensation aiguë. L'absence d'entourage empêche le suivi des symptômes et retarde l'alerte des secours lors d'une crise (infarctus ou AVC), réduisant les chances d'accès aux traitements d'urgence.	Les inégalités de santé : le poids des déterminants sociaux de santé - Santé Publique France, Accès aux soins et pratiques de recours - Drees, Les variables sociodémographiques dans le SNDS - health Data Hub, La solitude, l'isolement et la santé cardiaque Fondation des maladies du cœur et de l'AVC - coeuretavc

Logement et précarité énergétique	LOGEMEN T05, LOGEMEN T06 (confort thermique), LOGEMEN T03, LOGEMEN T04, LOGEMEN T02	L'exposition prolongée à un froid intérieur (< 18°C) augmente la résistance vasculaire et la pression artérielle. Le froid entraîne aussi une hémococoncentration (diminution du volume plasmatique), ce qui crée un climat propice aux infarctus du myocarde et AVC chez les personnes âgées. Enfin, la suroccupation et l'habitat indigne doublent le risque de détresse psychique grave et génèrent un stress chronique qui exacerbe la vulnérabilité cardiovasculaire.	Vivre dans un logement mal chauffé peut nuire à la santé mentale - Direct Assurance, Précarité énergétique et santé : état des connaissances et situation en Ile-de-France – Pollution atmosphérique, Santé et précarité énergétique - ONPE
Facteurs environnementaux (qualité de l'air, nuisances sonores...)	AIR01, AIR02 AIR05, AIR06 BRUIT02, BRUIT03, ADT01, ADT02 MOB02 (marche), MOB04, ADT03 à ADT06, INDUSTRI E01, SOLS01, SOLS02.	Les particules fines déclenchent un stress oxydatif et une inflammation systémique (hausse de la hsCRP), accélérant l'athérosclérose ; chaque hausse de 10 µg/m³ de PM2,5 à long terme augmente la mortalité par cardiopathie ischémique de 16 % et par AVC de 14 %. Le bruit des transports augmente le taux de cortisol et empêche la baisse tensionnelle nocturne, augmentant le risque d'infarctus. Les espaces verts protègent le système cardiovasculaire (baisse de la mortalité globale, HR = 0,94) en réduisant le stress et en filtrant les polluants et le bruit. La mobilité active (marche, vélo) et les infrastructures sportives réduisent drastiquement l'inactivité, le diabète et le risque de décès cardiovasculaire.	Mediating effect of the normalised difference vegetation index between PM2.5 and its components and cardiovascular disease - BMJOpen, Nighttime road traffic noise stresses the heart and blood vessels - escardio, Impacts of Urban Green on Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases - PMC

Offre de soins et l'Accessibilité Potentielle Localisée	APL-med_ genera, APL_Cardi o_EPCI, APL-chir_ dent, APL-kine, API-infirmie res, APL-sages _femmes.	Un faible indicateur APL en médecine générale ($\leq 2,5$ consultations/an/habitant) empêche le suivi régulier des patients souffrant d'affections de longue durée (hypertension, diabète, insuffisance cardiaque), entraînant une inertie thérapeutique et un manque de dépistage des complications. Cela provoque à terme un sur-recours tardif et évitable aux urgences hospitalières. Une faible accessibilité locale à la cardiologie (APL_Cardio_EPCI) nuit gravement à la mise en œuvre de la prévention secondaire après un infarctus (où la mortalité est de 12,2 % à un an, dont 70,6 % les 30 premiers jours), multipliant les récurrences.	Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes L'Observatoire des Territoires, Pratiques spatiales d'accès aux soins - Irdes, ACCESSIBILITÉ À UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET TAUX DE RECOURS AUX URGENCES - ORU Occitanie
--	---	---	---